意識消失発作（TLOC）の鑑別診断

— 失神・てんかん・PNESを7ステップで系統的に鑑別 —

ESC 2018 / NICE ガイドライン準拠

医知創造ラボ

TLOCの分類 — 4つの大カテゴリー

失神(Syncope)

脳血流の一過性低下
反射性(60%)/ 起立性 / 心原性

てんかん発作

GTCS / 焦点意識減損発作
/ 欠神発作

PNES

心因性非てんかん性発作
(機能性神経症状症)

まれな原因

椎骨脳底動脈TIA / 鎖骨下盗血
/ 低血糖 / SAH

初期評価の3本柱(ESC 2018)

① 詳細な病歴聴取

患者本人＋目撃者
これだけで50-60%は
診断可能

② 身体診察

臥位→立位血圧測定
(3分後)を必ず含む
起立性低血圧の検出

③ 12誘導心電図

全例に必須
心原性失神の
スクリーニング

💡 初期評価だけで過半数が診断可能 — 病歴聴取が最も重要

Step 1　誘因・状況 — 最初の分岐点

誘因	示唆される診断	重要度
長時間立位 / 痛み / 採血 / 感情ストレス	血管迷走神経性失神	一般的
排尿 / 咳嗽 / 嚥下時	状況失神	一般的
起立直後	起立性低血圧	一般的
運動中・労作中	心原性失神	🚨 赤旗
臥位・安静時	心原性（不整脈）	🚨 赤旗
睡眠中	てんかん	⚡ 重要
上肢運動中（片側）	鎖骨下動脈盗血症候群	まれ

Step 2　前駆症状 — 診断の宝庫

前駆症状	示唆される診断
発汗・悪心・蒼白・視野暗転	血管迷走神経性失神（自律神経症状）
立ちくらみ・ふらつき	起立性低血圧
デジャビュ / 上腹部不快感の上行 / 恐怖感	焦点発作（側頭葉てんかん）
動悸	不整脈性失神
突然の激しい頭痛	くも膜下出血
前駆症状なし（突然の意識消失）	心原性失神を最も疑う

🚨 **前駆症状なしの突然の意識消失 → 心原性失神を最も疑う**

Step 3　発作中の所見 — 目撃者情報が鍵

所見	失神	てんかん	PNES
顔色	蒼白	チアノーゼ	正常
持続時間	<30秒	1-2分	>5分
開眼/閉眼	開眼	開眼	閉眼★
運動パターン	多焦点性 ミオクローヌス （<10回）	強直間代 律動的 （>20回）	非同期性 側方動揺
舌咬傷	尖部（稀）	側面★ （LR+ 49）	尖部/なし
発作後の回復	速やか （<1分）	遷延混迷 （>5分）	変動的

⚠️ 痙攣性失神（Convulsive Syncope）

失神でも約12%に四肢のミオクローヌスが出現
→ てんかんと誤診しないこと！

10/20 ルール

ミオクローヌス < 10回
→ 失神を示唆
多焦点性・不規則・短時間

VS

ミオクローヌス > 20回
→ てんかんを示唆
律動的・全身同期性

舌咬傷の診断的価値

舌咬傷の部位	感度	特異度	LR+	示唆
舌咬傷(全般)	33%	96%	8.2	てんかん
舌側面の咬傷	11.3%	99.8%	49.3	てんかんにほぼ特異的
舌尖部の咬傷	—	—	—	失神 or PNES

🔑 臨床的位置づけ

- 舌側面の咬傷があれば → てんかんの診断はほぼ確実(LR+ 49)
- 感度は11%と低い → なくても除外はできない
- 舌尖部の咬傷 → 失神やPNESでも起こりうる → 鑑別には使えない

Step 4　発作後の所見 — 最も信頼できる鑑別点

失神

速やかな回復（<1分）
横になれば血流回復

てんかん

遷延する意識混濁（>5分）
筋肉痛・頭痛・CK上昇

PNES

変動的な回復パターン
発作中の記憶が部分的にあり

Todd麻痺（一過性片麻痺）

→ 焦点起始てんかんの診断がほぼ確実

発作中の出来事を部分的に記憶

→ PNESを示唆（てんかん・失神では稀）

PNES（心因性非てんかん性発作）— 5つのサイン

❶	**閉眼**	特異度92% — てんかん・失神は通常開眼
❷	**5分以上の持続**	真のてんかん発作は1-2分。5分超はPNESの可能性24倍
❸	**非同期性四肢運動**	不規則・骨盤突出運動も特徴的
❹	**変動する経過**	感度76% — 最も信頼できる徴候
❺	**発作中の部分的記憶**	てんかん・失神ではまず見られない

確定診断：ビデオ脳波モニタリング（vEEG）— 発作中の脳波が正常であることを確認

Step 5　心原性失神のレッドフラグ

🚨 **心原性失神は全失神の10%だが、2年死亡率17-21%**

- ⚡ 前駆症状なしの突然の意識消失
- 🏃 運動中・労作中の失神
- 🛏️ 臥位での失神
- 📊 心電図異常（QT延長、Brugada型、二束ブロック）
- 💗 構造的心疾患の既往 / 心不全の徴候
- 👪 40歳未満の突然死の家族歴
- 💓 失神前の動悸

1つでも該当 → 循環器内科への相談が必要

EGSYS Score — 心原性失神のスクリーニング

所見	点数
失神前の動悸	+4
心電図異常 and/or 心疾患	+3
労作中の失神	+3
臥位での失神	+2
自律神経性前駆症状（発汗・悪心・温感）	-1
誘因あり（温環境、長時間立位、恐怖、痛み）	-1

≧3点：心原性失神の感度92%・特異度69% — 2年死亡率17-21% → 入院精査を強く考慮

Step 6-7　患者背景・家族歴

📋 患者背景

- 若年者 → 血管迷走神経性が最多
- 高齢者 → 心原性・起立性・頸動脈洞
- てんかん既往 → てんかん発作
- 心疾患既往 → 心原性失神
- PD/DM → 起立性低血圧（自律神経障害）
- 精神疾患 → PNES
- 降圧薬/利尿薬 → 起立性低血圧
- インスリン/SU薬 → 低血糖

👪 家族歴

🚨 40歳未満の突然死
→ QT延長症候群
→ Brugada症候群
→ 肥大型心筋症

⚡ てんかんの家族歴
→ てんかんの素因

💗 チャネル病の家族歴
→ 心電図精査必須

検査アプローチ — 疑い別の追加検査

疑い	検査	備考
反射性失神	チルト試験、頸動脈洞マッサージ	再発性/不確実時。CSM>40歳
起立性低血圧	臥位→立位BP(3分後)	SBP↓20 or DBP↓10
不整脈性	ホルター、ILR、EPS	ILRは原因不明再発性に有用
構造的心疾患	心エコー、負荷試験、BNP	労作中失神→運動負荷試験
てんかん	EEG、頭部MRI	EEG1回の感度≈50%
PNES	ビデオ脳波モニタリング	確定診断のゴールドスタンダード
SAH	頭部CT(6h以内)、LP	6h以内のCT感度>98%

※ ルーチンのEEG・頭部画像は失神の初期評価としては非推奨(神経所見がない限り)

鑑別のまとめ

	失神	てんかん	PNES	心原性
顔色	蒼白	チアノーゼ	正常	—
持続	<30秒	1-2分	>5分	—
回復	速やか	遷延混迷	変動的	速やか
開閉眼	開眼	開眼	閉眼★	—
舌咬傷	尖部	側面★	稀	—
誘因	明確	なし/睡眠中	ストレス	労作/臥位
前兆	自律神経症状	デジャビュ等	—	動悸/なし

★ = 高い特異度を持つ所見

まとめ — Take Home Message

1. 初期評価は「病歴＋身体診察＋心電図」— 50-60%はこれで診断可能
2. 「蒼白 vs チアノーゼ」を目撃者に聞く — 失神 vs てんかんの最初の手がかり
3. 舌側面の咬傷（LR+ 49）→ てんかんにほぼ特異的
4. 閉眼（特異度92%）→ PNESの重要サイン
5. 前駆症状なしの突然の意識消失 → 心原性を最も疑う
6. 運動中失神 ＋ 突然死家族歴 → チャネル病/HCMの除外必須
7. EGSYS ≧3点 → 2年死亡率17-21%、入院精査を強く考慮